Síndrome de Down – Autismo - RM

Semana 18

Crecimiento y Desarrollo

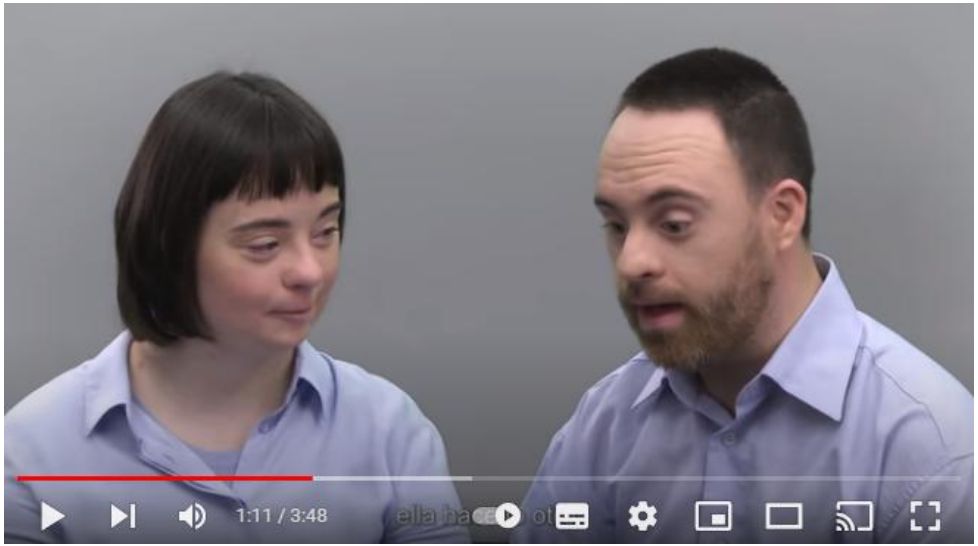
Presente.

Saberes previos:

¿Qué características físicas observas en el niño?

Extraído de: https://www.massgeneral.org/children/down-syndrome/sindrome-de-down-mosaico .

Observa el video



Enlace: https://www.youtube.com/watchv-kb8mJ0r8Guk

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital o el chat/audio

¿Qué es el síndrome de Down?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las clases, características y tratamiento del síndrome de Down, autismo y RM

Temario:

1. Concepto
2. Factores de riesgo
3. Etiología
4. Manifestaciones clínicas
5. Características físicas, motoras y cognitivas
6. Tratamiento fisioterapéutico

1. Concepto

El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra (o una parte de el) en la pareja cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres cromosomas en dicho par (de ahí el nombre de trisomía 21), cuando lo habitual es que existan dos.

1. Concepto

Es la causa mas frecuente de discapacidad cognitiva psíquica, congénita y se debe su nombre a John Landon Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866.

2. Factores de riesgo

Es desconocida, la única relación que se ha encontrado es la edad materna

A mas edad, mayor la posibilidad de concebir un niño con SD

La probabilidad a los 25 años es de 1 a 1250

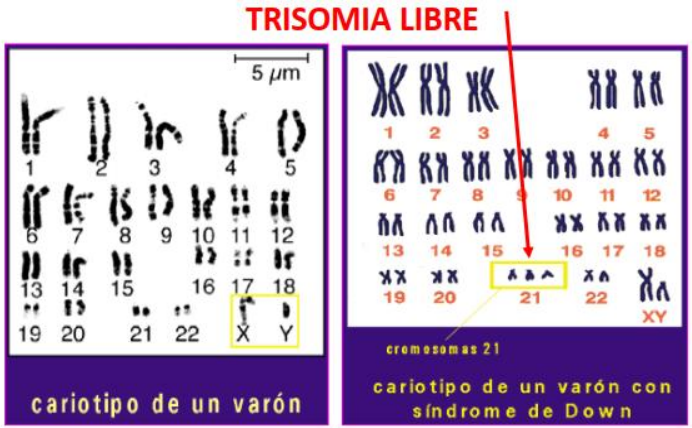
A los 40 años es de 1 en 100 y a los 45 de 1 en 50

3. Etiología

La existencia de un cromosoma 21 adicional se produce por uno de los siguientes mecanismos:

- Trisomía libre
- Translocación
- Mosaicismo

Trisomía libre

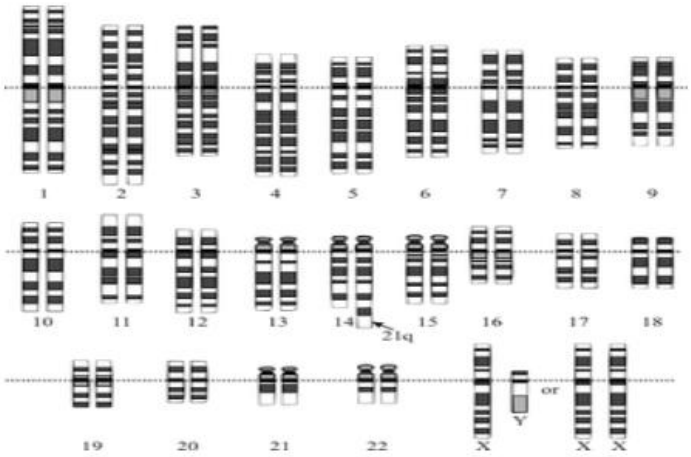


Alteración del cromosoma 21 (un cromosoma mas).

Responsable en un 95% de los casos de síndrome de Down

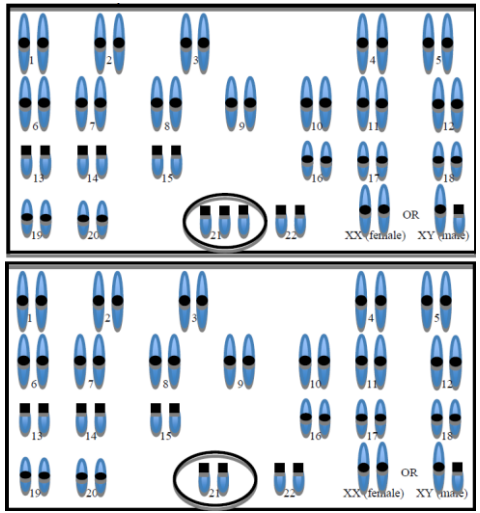
Único factor que presenta una asociación estadística estable con el SD es la edad materna.

Translocación



- Responsable de un 3% de los casos de síndrome de Down
- No se relaciona con la edad materna
- Exceso de material genético
- Necesidad de hacer un estudio genético a los progenitores

Mosaicismo



Presente en el 2% aproximadamente de los casos

Su característica principal: no todas las células presentan trisomía

El numero puede variar desde unas pocas hasta casi todas

4. Manifestaciones clínicas

Entre las características mas comunes tenemos:

- Hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa
- Desarrollo psicomotor muy lento
- Retardo mental acentuado

5. Características físicas, motoras y cognitivas

Características físicas

Características craneofaciales

- Braquicefalia
- Puente nasal deprimido
- Occipital aplanado
- Implantación baja de cabello
- Cuello corto
- Hipoplasia medio facial

5. Características físicas, motoras y cognitivas

Características físicas

Cara

- Ojos almendrados
- Fisuras palpebrales hacia arriba
- Manchas de Brusfiel
- Estrabismo
- Nistagmo
- Macroglosia

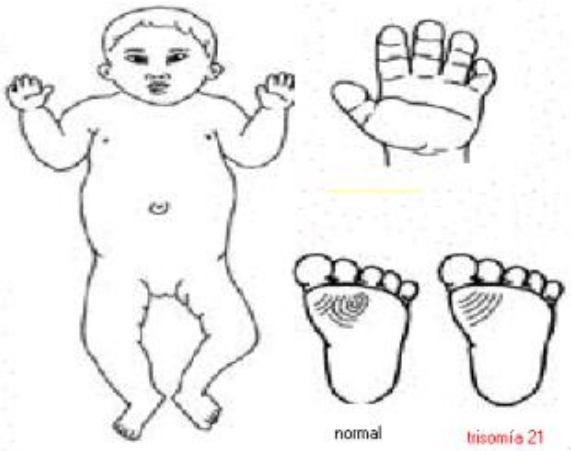
Pabellones auriculares:
Hélix muy delgado
Malformados y pequeños
Ausencia de lóbulos

Manos

- Pequeñas o cuadradas
- Braquidactilia
- Surco palmar único

Pies

- Espacio interdigital aumentado



5. Características físicas, motoras y cognitivas

Características motoras

- Alteraciones en la motricidad fina
- Disminución de la fuerza muscular
- Alteraciones del equilibrio estático y dinámico.
- Dificultad para subir escaleras o saltar hacia arriba.

5. Características físicas, motoras y cognitivas

Características cognitivas

- Dificultad para procesar información.
- Bloqueo en la atención
- Déficit en precepción
- Déficit en memoria a corto plazo
- Dificultad de lateralidad

6. Tratamiento fisioterapéutico

Los niños que padecen el Síndrome de Down pueden ser sujetos a los que se puedan aplicar métodos fiosterapeuticos para mejorar su vida diaria.

Los objetivos fundamentales serán:

- Desarrollo psicomotor del niño
- Motricidad gruesa

6. Tratamiento fisioterapéutico

- El fisioterapeuta se enfoca básicamente en la motricidad fina y gruesa.
- Motricidad fina: coordinación ojos-mano, alcanzar, sujetar, manipular objetos, resolver problemas, escribir, pinzar.
- Motricidad gruesa: involucra el control de cabeza, sentarse, ponerse de pie, arrastrarse, gatear, caminar, correr brincar, agacharse.
- Se debe comenzar con una evaluación y la elaboración de un programa de intervención fisioterapeuta teniendo en cuenta la edad, semanas o meses, cuando adquirieron ciertas habilidades y cuales no en cuanto a las áreas mencionadas.

6. Tratamiento fisioterapéutico

Se debe trabajar también la hipotonía muscular, la laxitud ligamentosa, la coordinación, el equilibrio y la marcha.
La actitud postural de estos niños en bipedestación se caracteriza por lo siguiente:

- Hombros ligeramente antepulsados
- Tendencia a la cifosis dorsal
- Abdomen prominente y
- Aumento de la lordosis lumbar

6. Tratamiento fisioterapéutico

También existen otras complicaciones como:

- Pie plano,
- Luxación de cadera,
- Escoliosis,
- Inestabilidad rotuliana y
- Alteraciones respiratorias que deben ser tratadas por estos especialistas de la salud.

Actividad sincrónica

Hagamos un cuadro descriptivo sobre las características físicas, motoras y cognitivas del síndrome de Down

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones

Aportes

Los niños con Síndrome de Down deben recibir tratamiento fisioterapéutico desde los primeros meses de vida, con el fin de mejorar su calidad de vida abarcando los aspectos cognitivos, psicomotrices, social, educativo, autonomía personal, etc.

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.